

标注手册 (Codebook)

发布说明：版本号V1.0，发布日期 2026-08-24，**第一轮标注依据本版执行。**

原则：只按本手册规则标注；规则未覆盖的个案标 flag=1 并在 note 列写一句话（不算缺失，交仲裁）。
双人独立标注，禁止互相看结果。所有"未见/无明显"否定表述优先于阳性词（先判否定再判阳性）。

域① H社区ECG（输入：ecg_text，一段结论文本）

输出列（多标签，各0/1）：

列	定义	判定规则
ecg_normal	正常心电图	含"正常心电图/大致正常/未见明显异常/正常范围"，且无任何下述异常
ecg_af	房颤/房扑	房颤、心房颤动、心房扑动、房扑（不含"窦性"）
ecg_pac_pvc	早搏	早搏、期前收缩、过早搏动（房性/室性均标1，无需区分）
ecg_stt	ST-T/缺血	ST-T改变、ST段（抬高/压低）、T波（低平/倒置/高尖）、心肌缺血； "未见ST-T改变"=0
ecg_avblock	房室传导阻滞	一/二/三度房室传导阻滞、I /II/III度AVB
ecg_bbb	束支/室内阻滞	左/右束支传导阻滞、分支阻滞、室内传导阻滞
ecg_rate	心率异常	窦性心动过速（>100）、窦性心动过缓（<60）；窦性心律（60-100）不算
ecg_srirr	窦性心律不齐	窦性心律不齐/窦性心动不齐（含错别字变体）
ecg_axis	电轴/转位/低电压	电轴左偏/右偏、顺/逆钟向转位、低电压
ecg_qwave_mi	异常Q波/陈旧性心梗	异常Q波、病理性Q波、陈旧性下壁/前壁梗死
ecg_other	其他器质异常	预激、逸搏、起搏器、房室分离、肥大/肥厚、紊乱性心律等
ecg_unreadable	无法判读	文本缺失/×/弃检/拒检/图像质量差

边界例：

- "窦性心律，一度房室传导阻滞，部分导联ST-T改变" → avblock=1, stt=1
- "未见ST-T改变，心电图大致正常" → normal=1
- "窦性心动过缓伴不齐（58bpm）" → rate=1, srirr=1
- "电轴不偏" → 不算axis异常

域② PG心脏echo（输入：echo检查所见全文）

输出列：

列	定义	判定规则
echo_normal	结构功能无异常	无任何下述异常，且瓣膜仅"未见/无"
echo_variant	少量/轻度返流	仅"少量/轻度/轻微"返流，无结构异常
echo_lvh	左室肥厚	室间隔或左室后壁厚度 $\geq 12\text{mm}$ （按数值），或明确写"室间隔/左室壁增厚"；二尖瓣/主动脉瓣增厚不算
echo_la_dilate	左房增大	左房内径 $\geq 40\text{mm}$ （按数值），或明确"左房增大/扩大"
ef_value	EF数值	抽取"射血分数（EF）：67"中的数字；无则空
ef_abnormal	EF<50	1/0
reflux_grade	返流分级	none/trace_mild(少量-轻度-轻微)/moderate(中量)/severe(大量)；"未见返流"=none
echo_rhythm	节律异常	房颤/早搏/起搏/传导阻滞等任一
echo_unreadable	无法判读	同上

边界例：

- "二尖瓣后叶增厚、回声增强" → 不算LVH（瓣膜增厚），若有中度返流则reflux=moderate
- "左房内径约41mm，余房室大小正常" → la_dilate=1
- "肝实质细密"出现在echo文本中 → 忽略（肝所见不属于echo域）

域③ 腹部超声（输入：超声所见文本 + 主检结果，两列分别标注后以超声所见优先）

输出列：

列	定义	判定规则
us_fatty	脂肪肝	明确"脂肪肝"；描述式阳性：实质回声细密(增强)+后方衰减+管道欠清 三要素 ≥ 2 即判阳性
us_fatty_degree	分度	轻/中/重（原文出现才标，否则空）
us_hepatic_other	其他肝病	血吸虫性肝病、肝囊肿(>10mm)、血管瘤、占位、肝硬化
us_gallstone	胆系	胆囊结石、息肉(记note大小)
us_kidney_cyst	肾囊肿	含"左/右/双"记note
us_unreadable	无法判读	×/弃检/无文字
main_discrepant	主检与超声不一致	主检结果有/无脂肪肝与本次超声所见矛盾时=1

边界例：

- "肝实质回声细密增强, 后方轻度衰减, 管道结构欠清" → fatty=1 (三要素3/3)
- "肝实质回声呈网络状、门脉管壁增厚 (血吸虫肝病)" → fatty=0, hepatic_other=1
- "回声不均匀"单独出现 → 不判脂肪肝, flag=1

通用规则

1. **否定优先**: 先扫"未见/无明显/无/不厚/不增宽"及其后8字窗口, 命中则该异常=0
2. **多标签并存**: 一个文本可同时标多个异常列
3. **不确定**: flag=1 + note 写明原因 (每份标注flag率预期<5%; >10%请停下反馈手册)
4. **速度**: ECG目标~40s/份, echo/腹超~90s/份; 不追求零犹豫, 仲裁机制兜底
5. **盲法**: 标注时不得查看LLM/词典的预填结果 (工作簿中不提供)